

みんなで考える「つながり」の医療

# — システム思考って何だろう? —

対象：全スタッフ | 10 分 | ガニエの 9 教授事象

---

# こんな経験、ありませんか？

## ある日の病棟で ...

- 看護師 A さん：「退院は明日って聞いてますけど、ケアマネさんまだ来てないですよ？ 」
- リハビリ B さん：「え、退院延期になったんじゃ？ 」
- 医師 C さん：「家族への説明は MSW さんがやってくれるって…」
- MSW D さん：「私、今日初めてこの患者さんの話聞いたんですけど…」

**みんな一生懸命やっているのに、なぜかうまく回らない。**

それは「人」の問題ではなく、 \*\* 「つながり方」の問題 \*\* かもしれません。

---

# 今日のゴール

この 10 分が終わったら：

1. \*\* ざっくり説明できる \*\*: 「システム思考」ってこういうこと、と同僚に伝えられる
2. \*\* 自分の仕事に 1 つ使える \*\*: 「つながり」を意識した行動を 1 つ始められる
3. \*\* 振り返れる \*\*: うまくいった / いかなかったを「仕組み」の視点で見られる

---

# 「システム思考」をひとことと言うと

## 木を見て、森も見る

いつもの考え方 | システム思考

「誰が悪い？」 | 「仕組みのどこが詰まっている？」  
問題を1つずつ潰す | 問題のつながりを見る  
うまくいかない → もっと頑張る | うまくいかない → やり方を変える

## WHO も言っています

「医療の人材は孤立した労働力ではなく、地域・教育・技術・お金・リーダーシップが \*\* つながったエコシステム \*\* の中にいる」

— WHO/NHS England ウェビナー（2026年1月）

**あなたも、このエコシステムの大事な一部です。**

---

# 3つのキーワード

## 1. つながりの輪（フィードバックループ）

忙しい → ミスが増える → 確認作業が増える → もっと忙しい → ...

- こういう「ぐるぐる」を見つけることが第一歩
- 悪い輪もあれば、良い輪もある（声かけ → 安心 → 余裕 → もっと声かけ）

## 2. 全体から生まれるもの（創発）

- 「いい人」を集めても「いいチーム」になるとは限らない
- チームの雰囲気・文化は、メンバーの \*\* 関わり方 \*\* から生まれる
- 1人の行動がチーム全体に波及する

## 3. 小さなツボ（レバレッジポイント）

- 全部を変えなくていい。 \*\*1箇所変えるだけ\*\* で全体が動くポイントがある
- 例：朝のカンファレンスで「今日退院の患者、準備 OK？」と一言聞くだけで退院調整がスムーズに

---

# やってみよう

## グループ対話（3～4人、3分）

**\*\* お題 \*\***: あなたの部署で「ぐるぐる回っている悪循環」を1つ見つけてください

例:

- ナースコール多い → 記録が後回し → 申し送りが雑に → 次の勤務者が困る → ナースコール対応が遅れる
- 薬の問い合わせが多い → 薬剤師が病棟に来られない → 疑義照会が溜まる → まとめて対応 → 待ち時間が長い

**\*\* 次に \*\***: その悪循環の中で「ここを1つ変えたら全体が良くなりそう」というポイントを見つけてください

---

# 明日からできること + 参考情報

## 職種別アクション

職種 | 明日からやってみること

看護師 | 申し送りで「この患者に関わっている人、全員伝わってる？」と確認

リハビリ | 退院に向けたリハ計画を、看護師・MSWと\*\*一緒に\*\*立てる場を作る

薬剤師 | 処方変更時に「この変更が患者の生活にどう影響するか」を一言添える

事務 | 予約・書類の流れで「ここで情報が止まっている」箇所を1つ見つける

全員共通 | 「なぜうまくいかないか」を\*\*人\*\*ではなく\*\*仕組み\*\*で考えてみる

## 覚えておきたい1つのこと

\*\* うまくいかないとき、「誰が悪い」ではなく「どこが詰まっている」と考える。 \*\*

それだけで、チームの会話が変わります。

## もっと知りたい方へ

- WHO — Embracing Complexity: Systems Thinking for Health Workforce (2026)
- ドネラ・メドウズ 著『世界はシステムで動く』（英治出版）— システム思考の入門書